

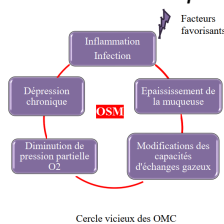
Objectifs pédagogiques

Introduction-
Définition

LES OTITES MOYENNES CHRONIQUES

I. Introduction

- Motif fréquent de consultation
- Diagnostic positif : Clinique + imagerie
- Formes cliniques multiples
- Formes subaigues – chroniques
- Relation : OMA – OSM – OMC
- Opposer :
 - OMC simples # Cholestéatomateuses ++
 - Formes stables (*N'évaluent pas vers les complications et traitées par les généralistes*) # évolutives (*Graves ++*)
- Forme subaigue : OSM
 - Fréquence enfant +++
 - Gravité adulte



Cercle vicieux des OMC

II. Etude clinique

→ TDD : L'otite muqueuse à tympan ouvert

1. Interrogatoire

- **ATCD** : Loco-régionaux et généraux , otologiques , rhino-sinusiens , allergiques ...
- **Circonstances de découverte** :
 - Otorrhée muqueuse ou purulente après rhino-pharyngite ou baigande
 - Surdit  souvent n glig e

2. Examen clinique :

a. **Otoscopie** : Microscope , endoscopie

- **Perforation** : non marginale
- **S cr tions** : muqueuses , collantes ,  paisses
- **Muqueuse** :  d mateuse
- **Osselets** : Intacts

b. **Examen ORL** : Complet et g n ral

- ❖ Nez et sinus , cavum+++ (**Toute OSM chez l'adulte est un cancer du cavum JPDC +++**)
- ❖ Examen g n ral
- ❖ Facteurs favorisants : Allergie , infection ORL , RGO ...
- ❖ Explorations fonctionnelles
- ❖ Surdit  de transmission

3. Imagerie m dicale

- Radio standard : incidence de Schuller ? +/- , pas d'int r t sauf si pathologie respiratoire associ e

- TDM des rochers +++

- Bilan ossiculaire
- Complications
- Signes indirects : cholest tome

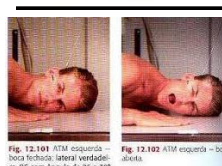
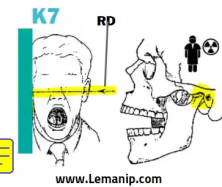
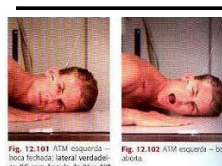
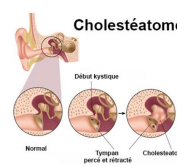
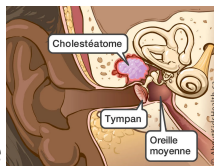
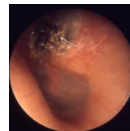


Fig. 12.101 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.102 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.103 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.104 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.105 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.106 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.107 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.108 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.109 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.110 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.111 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.112 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.113 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.114 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.115 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.116 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.117 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.118 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.119 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.120 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.121 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

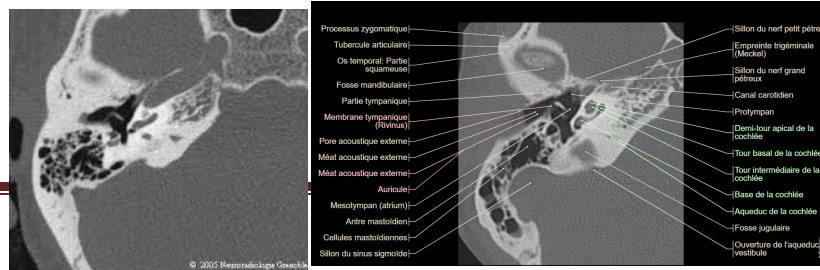
Fig. 12.122 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

Fig. 12.123 ATM osseuse - Vista Schuller: lateral vendicte, RC, com  ngulo de 25   30  caudalmente.

QE : TDM SI suspicion de lyse ossiculaire :    voquer si la surdit    l'audiogramme > 30dB (car atteinte du tympan seul peut au maximum engendrer une perte de 30dB) permet de contr ler l' tat de l'OM et pr voir la chirurgie   faire pour prendre en charge les s quelles

4. Evolution

- Stabilisation : S quelles le plus souvent



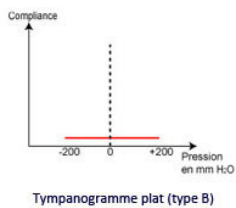
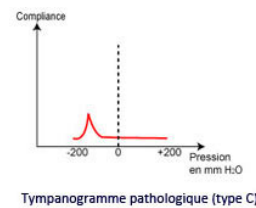
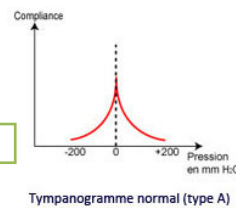
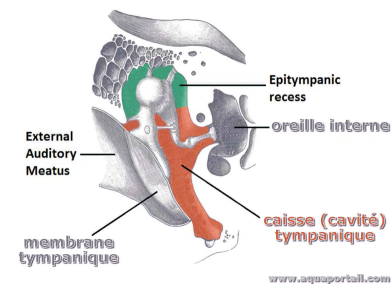
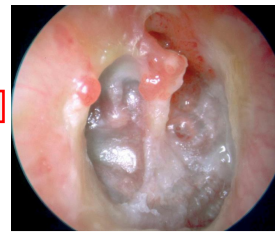
- Complications : Rares
 - Ostéite mastoïdienne
 - Epidermose OM = cholestéatome ++
 - Complications extra- et intracrânienne (PF et méningite ...)

III. Formes cliniques des OMC

1. Formes évolutives

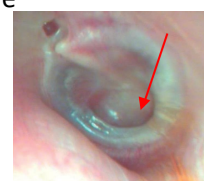
a. Otite adhésive

- Rétraction totale du tympan à la paroi interne de la caisse
- L'otite **adhésive** ou **fibro-adhésive**, conséquence d'une inflammation active de la muqueuse de la caisse aboutissant à la création d'une fibrose productive comblant la caisse du tympan
- La **pathogénie**, certainement multifactorielle, pose des problèmes complexes encore imparfaitement résolus
- **Microscopie** : Tympan grisâtre, rétracté moulant la chaîne
- **Impédancemétrie** : Courbe type b ou C
- **Audiométrie** : Surdit  de transmission
- **Sa thérapeutique** : préventive
- **Evolution** :
 - Surdit  de transmission
 - Surdit  mixte



b. Otite atelectasique

- Rétraction totale ou partielle (tympan – paroi interne caisse)
- **Pathogénie** : Dysfonctionnement tubaire et atteinte de la couche fibreuse tympanique
- **Microscopie** : Tympan fin, transparent, rétracté moulant la chaîne
- **Poche de rétraction** : Contr lable, auto-nettoyante et mobile
- **Impédancemétrie** : Courbe type b ou c
- **Audiométrie** : Surdit  de transmission
- **Evolution** : A partie d'une OSM ou d'une poche de rétraction, vers cholest atome +++ (QE)
- **Traitement** : Chirurgie de renforcement tympanique



c. OMC cholest omateuse : QEE ++

- **D finition** : Existence de tissu  pidermique dans les cavit s de l'oreille moyenne " The skin is in the wrong place "
- **Danger** : Pouvoir ost olytique
- **Diagnostic** : clinique++
- **Evolution** : Complications vitales et fonctionnelles
- **Traitement chirurgical** : Tympanoplastie de type III (EPM) ++
- **Traitement pr ventif** : Traitement de l'OSM ou d'une poche de r traction

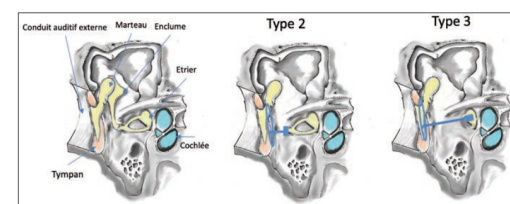


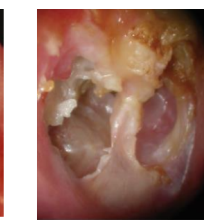
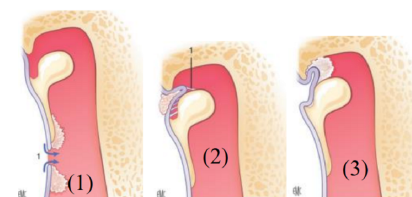
Figure n  1 | Classification des tympanoplasties de type II et III selon M. Portmann [1].

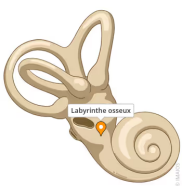
i. Pathog nie

- Epidermisation et atelectasie : R traction du tympan avec disparition de la couche fibreuse
- Poche de r traction non contr lable, non auto-nettoyante
- Rupture dans l'oreille moyenne
- Migration  pith liale   travers une perforation

ii. Examen clinique

- **Otoscopie** (aspiration sous microscope) :
 - Perforation post ro-sup ou totale et marginale
 - PDR non contr lable et non auto-nettoyante
 - C t  contralat ral chol  ou OMC simple





- Examen vestibulaire :

- Signe de Lucae : Pression du tragus → Trouble de l'équilibre avec nystagmus harmonieux le signe de lucae
- Autres signes vestibulaires



QE : Le cholestéatome détruit le labyrinthe osseux ⇔ absence de protection du labyrinthe membraneux. Lors de la pression du tragus, les mouvements d'air fond bouger le labyrinthe → vertige

- Examen rhinologique

- Examen neurologique : PF, abcès du cerveau (labyrinthite)

- Examen général : Etat aggravant (diabète, maladies respiratoires ...)

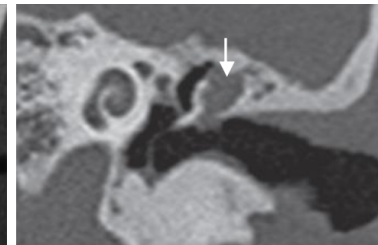
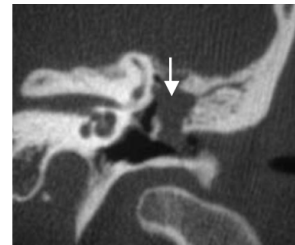
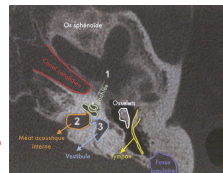
iii. Examens complémentaires

- Explorations fonctionnelles :

- Surdit  de transmission
- Surdit  fluctuante : Fistule labyrinthe

- Imagerie m dicale :

- Radiographie standard : Pas d'indication ++
- TDM des rochers ++ : Obligatoire pour  tudier l'extension, complications
- IRM des rochers : Surveillance, r cidive



TDM des rochers: Masse tissulaire convexe en faveur d'une OMC cholest atomateuse

iv. Les complications :

- ❖ Paralysie faciale : Chirurgie urgence
- ❖ Fistule labyrinthique : Clinique
- ❖ Labyrinthite aigu  : Urgence th rapeutique (signe de lucae + fi vre)
- ❖ Complications intracr niennes : m ningite, abc s
- ❖ Extensions extra-temporales : peau, cou, abc s extra et sous dural

Complications
intra-
temporales

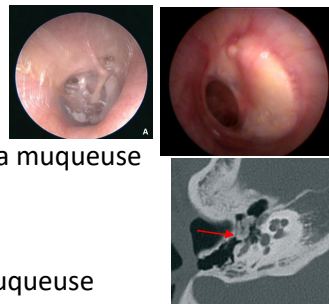


Lyse des parois osseuses de OM

2. Formes stables :

a. Tympanoscl rose :

- Tympanoscl rose : D p ts calcaires sur la muqueuse
- Microscopie :
 - Tympan perfor  ou non
 - D p ts blanch tres sur tympan et muqueuse
- Audiom trie tonale : Surdit  de transmission par blocage ou lyse de la cha ne ossulaire

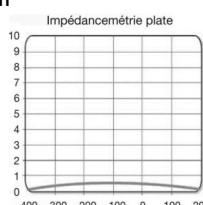


b. Otite s ro-muqueuse : QE +++

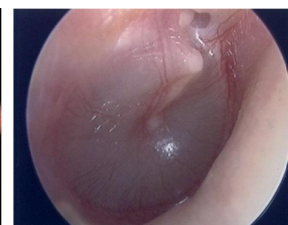
- Elle est d finie par l'association d'un  panchement de mucus et d'une d pression dans l'OM derri re un tympan ferm  d    l'inflammation chronique et une dysperm abilit  tubaire
- Touche essentiellement les enfants de 2   5 ans
- Survient dans les suites d'une OMA ou apr s des OMA r cidivantes
- Facteurs favorisants +++
 - ✓ Hypertrophie des v g tations ad no ides
 - ✓ Dysperm abilit  tubaire
 - ✓ Allergie respiratoire
 - ✓ Infection bact rienne remontent vers l'OM par la trompe
 - ✓ Cancer du rhinopharynx chez l'adulte, L'OSM y est souvent unilat rale +++

• Diagnostic

- Microscopie : Tympan
 - Epais, hypervascularisation radiaire
 - Aminci, niveau liquide, bulles d'air
- Audiogramme – imp dancem trie :
 - Surdit  de transmission



Oreille normale



Aspects otoscopiques OSM

➤ Courbe plate, décalée

Complications :

➤ Poussée aiguës d'OMC

➤ Cholestéatome

- Otite muqueuse à tympan ouvert

IV. Complications

❖ Mastoïdite aiguë +++ :

- Syndrome général important

- Tuméfaction inflammatoire rétro-auriculaire parfois collectée avec décollement du pavillon

❖ Paralysie faciale

❖ Fistule labyrinthique

❖ Labyrinthite = Vertige périphérique + fièvre + surdité

❖ Méningite et autres complications intracrâniennes (*méningo-encéphalite, abcès cérébral, thrombophlébite du sinus latéral*)

❖ Complications extracrâniennes

❖ Extensions extra-temporales (peau , cou ..)

V. Traitement

1. Traitement médical :

- Antibiothérapie : Amoxicilline protégée , céphalosporine pdt 10jours

- Corticothérapie : 0,5 à 1 mg/kg pdt 5 à 8 jours

2. Traitement adjuvant :

- Cures thermales

- Antihistaminiques

- Facteurs favorisants +++

3. Traitement chirurgical :

- Ablation des végétations (adénoïdectomie)

- Aérateur trans-tympanique (ATT)

- Tympanoplasties type I , II (otites simples)

- Tympanoplasties type III : en technique ouverte ou fermée (cholestéatome)

4. Indications :

- Traitement médical :

✓ Antibiothérapie si otorrhée purulente

✓ Corticothérapie si OSM

✓ Traitement adjuvants

- Traitement chirurgical :

✓ ATT + adénoïdectomie : OSM résistante au traitement médical ou récurrente

✓ Tympanoplastie : Perforation +/- lyse ossiculaire

✓ Cholestéatome : Exérèse +/- temps fonctionnel

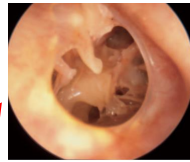
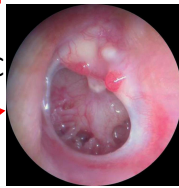
VI. Conclusion

- Otites dangereuses : cholestéatome + Adhésive + Atélectasique

- OSM : diagnostic et PEC

- OSM résistante au traitement médical/récurrente/avec grande surdité > 40dB chez l'enfant : traitement médico-chirurgical

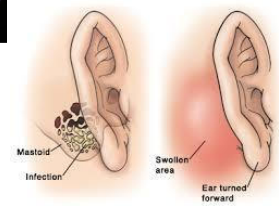
- Mesures d'hygiène d'une otite chronique : le cholestéatome est hydrophile, et entouré par une matrice qui a un caractère lysant. Le cholestéatome entre en contact avec l'eau, il augmente de taille et la matrice touche le VII et le lyse → d'où éviter les bains maures, la vapeur, les piscines = éviction de l'eau



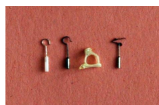
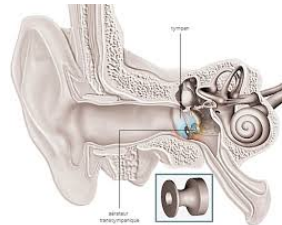
Oreille droite

Oreille gauche

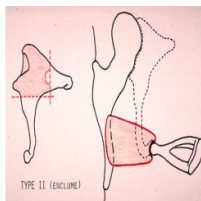
Otite moyenne chronique séquellaire:



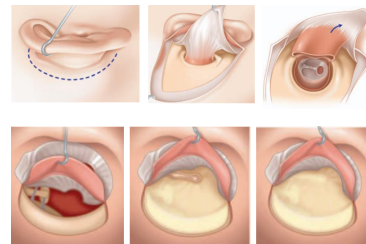
MAJOR COMPLICATIONS
① MASTOIDITIS
② OSTEOMYELITIS
③ BRAIN ABSCESS



Prothèses auditives



ossiculoplastie



Les étapes d'une tympanoplastie simple

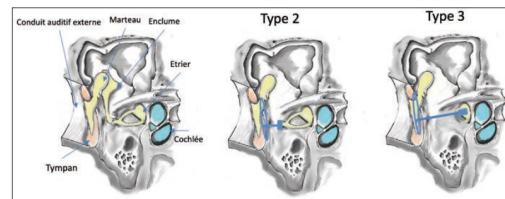
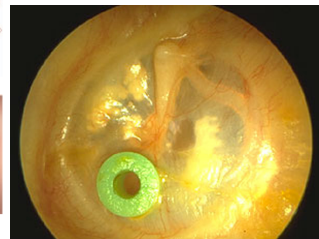
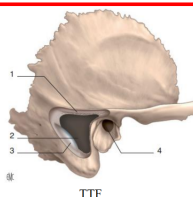
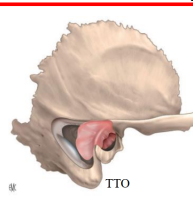


Figure n° 1 | Classification des tympanoplasties de type II et III selon M. Portmann [1].



TTF



TTO

